

To biologia traumy *nie „wybór” ani „typ”*

Osoby z historią traumy dziecięcej mają 2–3× wyższe ryzyko ponownej wiktylizacji (Classen, 2005). Mechanizm nie jest „magnetyczny” — jest neurobiologiczny.

CZAS: 10 min psychoedukacji + dalsza praca **REALIZACJA:** po stabilizacji, gdy temat się pojawi

ŹRÓDŁO: Classen, Palesh & Aggarwal (2005, metaanaliza, ryzyko 2–3×); Bowlby (1969, *Internal Working Models*); Porges (2011, neurocepcja); Russell (1986, pierwsza dokumentacja); Liotti (przywiązanie zdeorganizowane)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **fakt statystyczny** i jego znaczenie: 2–3× wyższe ryzyko, ale to *nie* wina ofiary. W sekcji 02 — **pięć mechanizmów**: zniekształcone modele relacyjne, osłabiona neurocepcja, internalizacja wstydu, dysregulacja emocji, biologiczna dysregulacja. Sekcja 03 — **praca ochronna**: trening rozpoznawania sygnałów, schemat, sieć wsparcia.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Rewiktylizacja to **powtarzające się doświadczenie wiktylizacji** u osób z historią traumy — i *nie* jest „przyciąganiem”. Catherine Classen, Oxana Palesh i Rashi Aggarwal (2005, metaanaliza, *Trauma, Violence & Abuse*): osoby z traumą dziecięcą mają **2–3× wyższe ryzyko** przemocy seksualnej, fizycznej, psychicznej w dorosłości. To *nie* jest „wina ofiary” ani „wybieranie” toksycznych partnerów — to mechanizm wynikający z **pięciu czynników** biopsychospołecznych: (1) **zniekształcone modele relacyjne** — „przemoc = norma”, „miłość = ból” — znormalizowane doświadczenia z dzieciństwa tworzą „szablony” relacji (Bowlby, 1969, *Internal Working Models*); (2) **osłabione rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych** — dysregulacja emocji osłabia zdolność do oceny zagrożenia w relacji („czuję dyskomfort, ale nie wiem, czy to normalne, bo zawsze czułem dyskomfort”); (3) **niska samoocena i zinternalizowany wstyd** — „na więcej nie zasługuję”, „nikt normalny mnie nie zechce”; (4) **dysregulacja emocji** — impulsywność w tworzeniu relacji (ang. *instant intimacy*), trudność z kończeniem toksycznych relacji; (5) **biologiczna dysregulacja** — chroniczny stres zmienia ostrzegawczy system nerwowy (Porges, 2011): osłabiona neurocepcja bezpieczeństwa i zagrożenia, ciało nie „zauważa” sygnałów alarmowych, które rozpoznałby układ nerwowy bez historii traumy. **Klinicznie:** klientka po przemocy domowej wchodzi w nową relację, partner okazuje się również przemocowy. Otoczenie komentuje: „jak mogłaś znowu wybrać takiego”, „masz typ”. Klientka internalizuje wstyd, czuje się „uszkodzona” — co **paradoksalnie** zwiększa ryzyko kolejnej wiktylizacji (zinternalizowany wstyd jest mechanizmem 3). Praca terapeutyczna: psychoedukacja (rewiktylizacja to biologia traumy, nie wybór), Schema Therapy + STAIR (modele relacyjne), trening rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, wspierająca sieć społeczna. **Trauma bonding** (intermittent reinforcement — przeplatanie krzywdy z okresami bliskości) tworzy intensywne, paradoksalne więzi — neurobiologicznie tłumaczy „dlaczego nie odeszłam”.

01 Fakt statystyczny — i co z niego nie wynika

CO WYNIKA Z BADAŃ

Classen, Palesh & Aggarwal (2005, metaanaliza): osoby z traumą dziecięcą mają **2–3× wyższe** ryzyko przemocy w dorosłości — seksualnej, fizycznej, psychicznej. Russell (1986): pierwsza dokumentacja. Ryzyko statystyczne, nie przeznaczenie.

CZEGO Z TEGO *NIE* WYNIKA

Nie wina ofiary. **Nie** „przyciąganie”. **Nie** „typ”. **Nie** osobowość. To *statystyczne* ryzyko wynikające z biologii i psychologii traumy — można je zrozumieć i z nim pracować.

02 Pięć mechanizmów rewiktymizacji

MECHANIZM	JAK DZIAŁA
1 · Zniekształcone modele	„Przemoc = norma”, „miłość = ból”. Modele relacyjne (Bowlby, 1969, <i>Internal Working Models</i>) z dzieciństwa tworzą „szablony” — przemocowy partner czuje się <i>znajomo</i> , nie alarmująco.
2 · Osłabiona neurocepcja	Porges (2011): nieświadome wykrywanie zagrożenia osłabione po latach chronicznej traumy. „Czuję dyskomfort, ale nie wiem, czy to normalne — zawsze czułem dyskomfort”.
3 · Zinternalizowany wstyd	„Na więcej nie zasługuję”, „nikt normalny mnie nie zechce”. Wstyd obniża próg, przy którym tolerujemy złe traktowanie.
4 · Dysregulacja emocji	Impulsywność w tworzeniu relacji (ang. <i>instant intimacy</i>). Trudność z kończeniem toksycznych relacji mimo wiedzy, że szkodzą.
5 · Trauma bonding	Naprzemienne wzmocnienie (krzywda + okresy bliskości) tworzy <i>silniejszą</i> więź neurobiologiczną niż stała życzliwość. Tłumaczy „dlaczego nie odeszłam”.

03 Moja mapa ochronna

MOJE TYPOWE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE W RELACJACH

— co zwykle czuję już na początku, a co racjonalizuję; sygnały ciała przed myśleniem

SYGNAŁY ZEWNĘTRZNE, KTÓRYCH CHCĘ SZUKAĆ

— love bombing, przekraczanie granic od początku, gwałtowne huśtawki emocjonalne, izolacja od bliskich, kontrolowanie

MOJA SIEĆ KONTROLI — KTO MI POWIE PRAWDĘ

— 1–3 osoby, którym ufam, że powiedzą szczerze, gdy widzę czerwone flagi w mojej nowej relacji

CO ODPOWIEM ZINTERNALIZOWANEMU WSTYDOWI

— gdy pojawi się „nie zasługuję na więcej” — przygotowane przeciwzwanie, np. „to głos krzywdziciela, nie prawda”

Klucz: rewiktymizacja *nie* jest „wadą charakteru” ani „magnetycznym przyciąganiem” przemocowych partnerów. To *biologiczna i psychologiczna* konsekwencja traumy — można ją zrozumieć i można z nią pracować. Najbardziej szkodliwe są komentarze otoczenia: „*masz typ*”, „*jak mogłaś znówu*”, „*sama wybierasz*” — te komentarze *wzmacniają* zinternalizowany wstyd, który jest mechanizmem 3 rewiktymizacji. Im więcej wstydu, tym wyższe ryzyko kolejnej wiktymizacji. To *nie* klientka „nie nauczyła się” — to jej układ nerwowy *nie miał* kalibracji dla bezpiecznych relacji w dzieciństwie. Praca terapeutyczna: *nie* uczenie „*wybijania lepiej*”, ale *kalibracja neurocepcji* (Porges) — przez korekcyjne doświadczenia bezpiecznych relacji (terapeuta, grupa, przyjaciele), trening rozpoznawania sygnałów (Schema Therapy + STAIR moduł 2), praca z wstydem (CFT).

△ Jeśli czytasz to w przemocowej relacji — bezpieczeństwo jest pierwsze, nie zrozumienie mechanizmów. Niebieska Linia: 800 12 00 02 (codziennie 24/7). Specjalistyczne ośrodki interwencji kryzysowej w każdym województwie. Plan ucieczki opracowuj poza domem sprawcy. Praca nad mechanizmami rewiktymizacji odbywa się po osiągnięciu bezpieczeństwa fizycznego, nigdy w jego miejscu.